Declaración de Trabajo de Arquitectura del Hospital de Tingo María: Alcance, Plan y Compromisos para el Desarrollo de la Arquitectura Empresarial

Historial de versiones

Tabla 1
Historial de versiones del documento

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción del cambio
1.0	15/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Emisión inicial: patrocinadores, objetivos, alcance, limitaciones, hitos, presupuesto y condiciones previas.
2.0	20/10/2026	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto	Revisión integral conforme al contenido típico de la Declaración de Trabajo en TOGAF 9.1: se incorporan antecedentes, resumen de la visión, alcance en cuatro dimensiones, enfoque de gestión, procedimiento de cambio de alcance, matriz de responsabilidades, entregables del proyecto, criterios y procedimiento de aceptación, plan de trabajo por semanas, presupuesto referencial y riesgos con nivel inicial y residual. Se alinea con la Visión de la Arquitectura v2.0 y con el cronograma unificado.

Información de seguimiento

Tabla 2
Datos de seguimiento del entregable

Campo	Valor
Nombre del proyecto	Arquitectura Empresarial — Hospital de Tingo María
Entregable TOGAF	Declaración de Trabajo de Arquitectura (*Statement of Architecture Work*)
Elaborado por	Equipo de Arquitectura Empresarial del proyecto
Versión	2.0 (borrador para aprobación)
Fecha de la versión	20/10/2026
Revisado por	Architecture Review Board (ARB)
Aprobado por	Director(a) Ejecutivo(a) del Hospital de Tingo María (patrocinador)
Fecha prevista de aprobación	Semana 8 (fin del Mes 2, cierre de la Fase A)

Lista de distribución

Tabla 3
Destinatarios del documento y acción esperada

Destinatario	Acción	Fecha límite	Medio
Dirección Ejecutiva (patrocinador)	Aprobar y firmar	Semana 8	Sesión del ARB y documento firmado
Architecture Review Board (ARB)	Revisar y recomendar aprobación	Semana 7	Sesión del ARB
Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Revisar y completar el presupuesto	Semana 6	Correo institucional
Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Revisar compromisos técnicos	Semana 6	Correo institucional
Dirección Asistencial	Revisar compromisos de participación clínica	Semana 6	Correo institucional
Dirección de Administración	Informar	Semana 8	Correo institucional

Resumen

La Declaración de Trabajo de Arquitectura es el acuerdo formal entre el patrocinador del Hospital de Tingo María y el equipo de arquitectura sobre qué se hará, cómo, con qué recursos, en qué plazo y con qué criterios se aceptará el trabajo. Este documento responde a la Petición de Trabajo de Arquitectura emitida en la Fase Preliminar y traduce la Visión de la Arquitectura en un compromiso ejecutable. Establece siete objetivos de arquitectura con indicadores medibles, delimita el alcance en las cuatro dimensiones que propone TOGAF 9.1 con foco en la cadena de atención de consulta externa, y define el enfoque de gestión, el procedimiento de cambio de alcance y una matriz de responsabilidades para patrocinador, ARB, equipo de arquitectura y áreas del hospital. Asimismo, presenta los entregables de las Fases A a G con sus criterios de aceptación, un plan de trabajo de 24 semanas y un presupuesto referencial de corto plazo, cuya validación corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Finalmente, enumera las condiciones que deben cumplirse antes de la firma, entre ellas la instalación del ARB y la formalización de la función de arquitectura, y registra los riesgos del proyecto con su nivel inicial y residual. Con la aprobación de este documento concluye la Fase A y se autoriza el inicio de la Fase B.

Palabras clave: TOGAF 9.1, declaración de trabajo de arquitectura, gobierno de la arquitectura, alcance, plan de proyecto, hospital público

Contenido

Resumen **2**
1. Introducción **5**
1.1 Propósito del documento 5
1.2 Contenido mínimo según TOGAF 5
1.3 Entradas y salidas 6
2. Antecedentes y petición de trabajo **6**
2.1 Antecedentes 6
2.2 Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06) 6
3. Resumen de la Visión de la Arquitectura **7**
4. Patrocinio y gobierno **8**
4.1 Patrocinador 8
4.2 Estructura de gobierno 8
5. Objetivos de la arquitectura y criterios de éxito **9**
6. Descripción y alcance del proyecto **10**
6.1 Descripción del proyecto 10
6.2 Alcance en las cuatro dimensiones de TOGAF 11
6.3 Contenido incluido por dominio 11
6.4 Fuera del alcance 11
7. Limitaciones y restricciones **12**
7.1 Limitaciones organizacionales 12
7.2 Limitaciones presupuestarias 12
7.3 Limitaciones externas y normativas 12
8. Enfoque de gestión **13**
8.1 Método de trabajo 13
8.2 Seguimiento y reportes 13
8.3 Escalamiento 13
8.4 Gestión de la calidad 13
8.5 Gestión documental 14
8.6 Gestión de la comunicación 14
9. Procedimiento de cambio de alcance **14**
9.1 Pasos del procedimiento 14
9.2 Clasificación de cambios 15
10. Roles, responsabilidades y entregables **16**
10.1 Roles del proyecto 16
10.2 Entregables del proyecto 17
10.3 Matriz de responsabilidades (RACI) 18
11. Criterios y procedimiento de aceptación **19**
11.1 Criterios generales 19
11.2 Criterios específicos 19
11.3 Procedimiento de aceptación 19
12. Plan de trabajo y cronograma **20**
12.1 Cronograma por fases 20
12.2 Plan detallado de actividades 21
12.3 Hitos de control 21
13. Condiciones previas a la aprobación **22**
14. Información presupuestaria **23**
14.1 Nivel 1: presupuesto de corto plazo (desarrollo de la arquitectura) 23

14.2 Nivel 2: presupuesto de largo plazo (implementación de la arquitectura) 24
15. Supuestos y riesgos del proyecto 24
15.1 Supuestos 24
15.2 Riesgos del proyecto 25
16. Conclusiones 26
17. Referencias 26
18. Apéndices 27
Apéndice A. Siglas 27
Apéndice B. Trazabilidad entre la petición, los objetivos y los entregables 27
Apéndice C. Formato de solicitud de cambio 27
19. Hoja de aprobación 28
19.1 Aprobación del patrocinador 28
19.2 Aprobación del Architecture Review Board 28
19.3 Conformidad del equipo de arquitectura 28

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

En TOGAF 9.1, la Declaración de Trabajo de Arquitectura define el alcance y el enfoque que se utilizarán para completar un ciclo de desarrollo de la arquitectura, y es el documento contra el cual se mide la ejecución exitosa del proyecto (The Open Group, 2011, cap. 36). Funciona como un contrato entre la organización de arquitectura y quien la solicita: deja por escrito lo que ambas partes esperan, de manera que cualquier desacuerdo posterior pueda resolverse revisando lo pactado (Josey, 2011).

Concretamente, este documento:

1. Responde formalmente a la Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06).
2. Define los objetivos, el alcance y las limitaciones del trabajo de arquitectura.
3. Establece cómo se gestionará el proyecto, cómo se manejarán los cambios y quién es responsable de qué.
4. Especifica los entregables, sus criterios de aceptación, el plan de trabajo y el presupuesto.
5. Enumera las condiciones que deben cumplirse para que el documento surta efecto.

1.2 Contenido mínimo según TOGAF

La siguiente tabla muestra dónde se cubre cada contenido que TOGAF recomienda para este entregable.

Tabla 4
Correspondencia entre el contenido típico de TOGAF y las secciones del documento

Contenido típico de la Declaración de Trabajo (TOGAF 9.1)	Sección
Título de la Declaración de Trabajo	Carátula
Petición y antecedentes del proyecto de arquitectura	2
Descripción y alcance del proyecto	6
Resumen de la Visión de la Arquitectura	3
Enfoque de gestión	8
Procedimiento de cambio de alcance	9
Roles, responsabilidades y entregables	10
Criterios y procedimientos de aceptación	11
Plan y cronograma del proyecto de arquitectura	12
Aprobaciones	19

Nota. Adaptado de *TOGAF Version 9.1* (cap. 36), por The Open Group, 2011, Van Haren Publishing. Se añaden, por exigencia del contexto institucional, las secciones de patrocinio (4), objetivos (5), limitaciones (7), condiciones previas (13), presupuesto (14) y riesgos (15).

1.3 Entradas y salidas

Tabla 5
Ubicación del documento en el ciclo ADM

Tipo	Elemento
Se produce en	Fase A (paso 11: desarrollar la Declaración de Trabajo y obtener su aprobación)
Entradas principales	Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06); Visión de la Arquitectura (A-01); Evaluación de Capacidades (A-04); Modelo Organizacional para la Arquitectura Empresarial (D-02)
Se utiliza como insumo en	Fases B, C, D, E, F y G, como referencia de alcance, plan y criterios de aceptación
Se actualiza	Cuando el ARB aprueba un cambio de alcance (sección 9), generando una nueva versión

2. Antecedentes y petición de trabajo

2.1 Antecedentes

El Hospital de Tingo María es un establecimiento de salud público dependiente del Gobierno Regional de Huánuco, que atiende a la población de la provincia de Leoncio Prado y a pacientes referidos de establecimientos de menor complejidad. La Evaluación de Capacidades (A-04) mostró que la información clínica está dispersa, que la atención se organiza alrededor de los servicios y no del paciente, que la infraestructura tecnológica no está priorizada y que no existe una función formal que gobierne el cambio tecnológico. A ello se suman obligaciones externas: el marco nacional de historias clínicas electrónicas (Ley N.° 30024, 2013), la protección de los datos de salud como datos sensibles (Ley N.° 29733, 2011) y las obligaciones de gobierno digital (Decreto Legislativo N.° 1412, 2018).

2.2 Petición de Trabajo de Arquitectura (D-06)

En la Fase Preliminar, la Dirección emitió la Petición de Trabajo de Arquitectura, en la que solicita los siguientes cambios:

Tabla 6
Cambios solicitados en la Petición de Trabajo y respuesta de esta Declaración

N.°	Cambio solicitado por la Dirección	Respuesta en esta Declaración	Objetivo asociado
1	Automatizar el flujo de atención en consulta externa, desde la admisión hasta la atención especializada	Se adopta como foco de la primera iteración	OA-02
2	Integrar la información clínica del paciente en un expediente único y accesible	Se adopta como eje de la arquitectura objetivo	OA-01
3	Reducir los tiempos de espera entre etapas de la atención	Se adopta, con línea base a medir en el Mes 3	OA-02
4	Elevar la seguridad y la privacidad de la información clínica	Se adopta como preocupación transversal	OA-03
5	Incorporar el seguimiento de los indicadores del Plan Operativo Institucional	Se adopta, sujeto a la vigencia del instrumento	OA-07

Además de lo solicitado, la Visión de la Arquitectura (A-01) añadió tres objetivos necesarios para que los anteriores sean sostenibles: interoperabilidad sectorial (OA-04), formalización de la función de arquitectura (OA-05) y capacitación del personal (OA-06).

3. Resumen de la Visión de la Arquitectura

La Visión de la Arquitectura (A-01) establece que, en un horizonte de 24 meses, el hospital contará con un Expediente Clínico Electrónico Único por paciente, alineado con el marco nacional de historias clínicas electrónicas; procesos de atención centrados en el paciente, empezando por la consulta externa; información clínica protegida por control de acceso, cifrado y auditoría; intercambio de información con la DIRESA Huánuco, el Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud mediante estándares abiertos; infraestructura resiliente frente a cortes de energía y conectividad; y una función de arquitectura formal gobernada por el ARB.

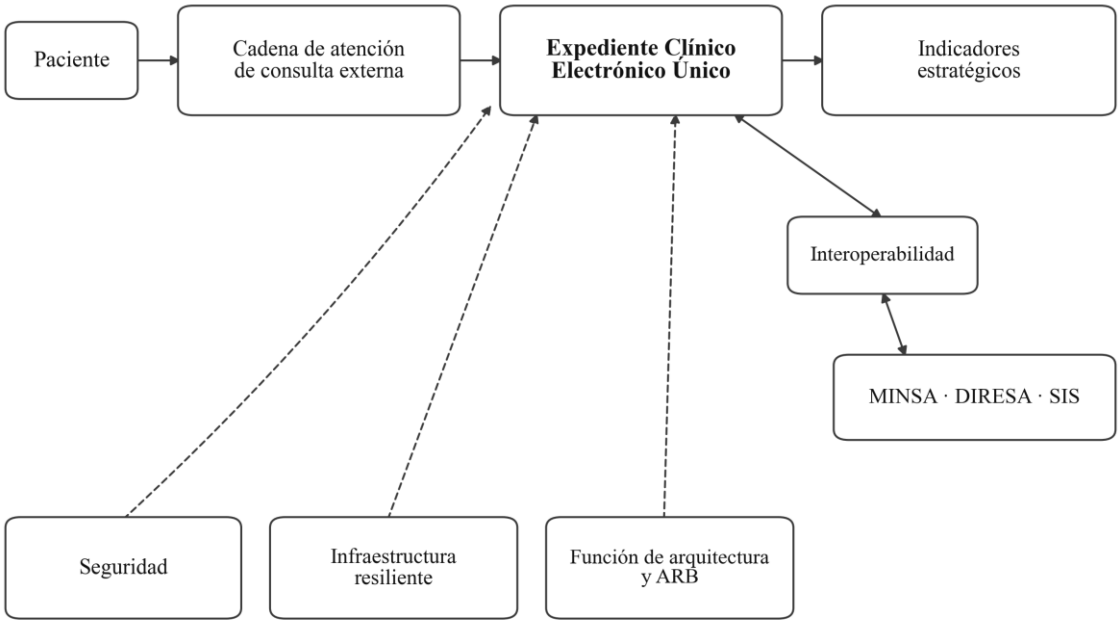


Figura 1
Concepto de la solución resumido

Nota. Versión resumida de la Figura 1 de la Visión de la Arquitectura (A-01).

4. Patrocinio y gobierno

4.1 Patrocinador

TOGAF recomienda que el trabajo de arquitectura tenga un patrocinador identificado con autoridad para comprometer recursos y resolver conflictos (The Open Group, 2011, cap. 7). La versión 1.0 registraba cuatro "patrocinadores"; se corrige para distinguir al patrocinador único de los aprobadores y responsables de área.

Tabla 7
Patrocinador y responsables institucionales

Rol	Cargo	Responsabilidad en el proyecto	Nombre
Patrocinador	Director(a) Ejecutivo(a) del Hospital de Tingo María	Aprueba esta Declaración; asigna recursos; preside el ARB; decide los cambios críticos	[Por designar mediante resolución]
Responsable del negocio clínico	Director(a) Asistencial	Garantiza la participación del personal clínico; valida procesos y requisitos clínicos	[Por designar]
Responsable financiero	Jefe(a) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto	Valida el presupuesto y los indicadores estratégicos	[Por designar]
Responsable tecnológico	Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información (OSI)	Facilita información técnica; asume la operación futura	[Por designar]

Nota. Mientras el patrocinador no sea designado formalmente y no firme la sección 19, esta Declaración no genera compromisos vinculantes para el hospital.

4.2 Estructura de gobierno

Tabla 8
Instancias de gobierno del proyecto

Instancia	Integrantes	Decide sobre	Frecuencia
Patrocinador	Director(a) Ejecutivo(a)	Aprobación final, recursos, cambios críticos	Hitos de fase y escalamientos
Architecture Review Board (ARB)	Director(a) Ejecutivo(a) (preside), Director(a) Asistencial, Director(a) de Administración, jefe de Planeamiento y Presupuesto, jefe de la OSI; arquitecto líder como secretario sin voto	Aprobación de entregables, excepciones a principios, cambios mayores	Quincenal
Comité de Seguimiento del Proyecto	Arquitecto líder, arquitectos de dominio, enlace clínico, enlace de la OSI	Avance, riesgos, cambios menores, preparación de la agenda del ARB	Semanal (30 minutos) y mensual (informe)

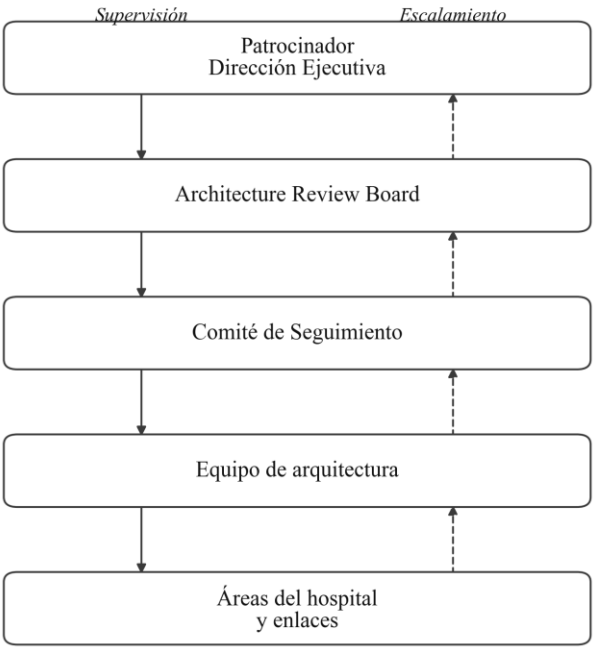


Figura 2
Estructura de gobierno y escalamiento

Nota. Las flechas continuas indican dirección y supervisión; las punteadas, la ruta de escalamiento de problemas y decisiones.

5. Objetivos de la arquitectura y criterios de éxito

Los objetivos provienen de la Visión de la Arquitectura (A-01, sección 11.4). Cada uno tiene un indicador con línea base y meta, de modo que el éxito del trabajo pueda comprobarse de forma objetiva.

Tabla 9

Objetivos de arquitectura, resultados esperados y criterios de éxito

Código	Objetivo de arquitectura	Resultado que entrega el trabajo de arquitectura (Mes 6)	Indicador de éxito de la arquitectura implementada (24 meses)
OA-01	Expediente clínico electrónico único, accesible y completo por paciente	Arquitectura de datos y aplicaciones del expediente aprobada, alineada al RENHICE	KPI-01: 95 % de consultas con registro completo
OA-02	Reducción del tiempo de espera en consulta externa	Proceso objetivo de consulta externa (EB-01) aprobado	KPI-02: 30 minutos o menos desde la llegada hasta la consulta
OA-03	Seguridad de los datos clínicos con control de acceso, cifrado y auditoría	Arquitectura de seguridad y matriz de acceso por rol aprobadas	KPI-03: 100 % de accesos auditados
OA-04	Interoperabilidad con la DIRESA, el MINSA y el SIS	Catálogo de interfaces y estándares acordado con las contrapartes	KPI-04: 3 interfaces sectoriales operativas
OA-05	Función de arquitectura formalizada y operativa	Función formalizada y ARB instalado (Mes 2); procedimientos de gobierno entregados (Mes 6)	KPI-05: función formalizada al cierre de la Fase A
OA-06	Plataforma de capacitación para el personal de salud	Requisitos y arquitectura de la plataforma aprobados	KPI-06: 40 horas o más de capacitación por profesional al año
OA-07	Tablero de control con indicadores estratégicos	Modelo de indicadores y fuentes de datos aprobados	KPI-07: 100 % de indicadores con dato vigente

Nota. El trabajo de arquitectura cubierto por esta Declaración termina en el Mes 6 con la arquitectura, la hoja de ruta y el modelo de gobierno de la implementación. Los indicadores a 24 meses miden la arquitectura una vez implementada y sirven para comprobar, en la Fase H, que la arquitectura entregó el valor prometido. Las fórmulas, fuentes y responsables de cada KPI se encuentran en A-01 (Tabla 32).

6. Descripción y alcance del proyecto

6.1 Descripción del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar, en seis meses, la primera iteración completa del ADM de TOGAF 9.1 para el Hospital de Tingo María, desde la Fase A hasta la Fase G. Su producto no es un sistema informático, sino un conjunto de arquitecturas aprobadas, una hoja de ruta de implementación y un modelo de gobierno que permitirán al hospital adquirir o desarrollar las soluciones correctas, en el orden correcto y bajo control.

6.2 Alcance en las cuatro dimensiones de TOGAF

Tabla 10
Alcance del trabajo de arquitectura

Dimensión	Alcance acordado
Amplitud	Hospital de Tingo María, con foco en la cadena de atención de **consulta externa** (admisión, citas, triaje, consulta, órdenes de laboratorio e imágenes, prescripción, dispensación y registro de la prestación). Hospitalización y emergencia se modelan solo a nivel de contexto, para asegurar compatibilidad en iteraciones posteriores.
Profundidad	Nivel estratégico y de segmento: procesos de nivel 1 y 2; modelo lógico de datos; portafolio de aplicaciones y servicios de aplicación; servicios y plataformas tecnológicas. No incluye diseño detallado de soluciones.
Horizonte temporal	Desarrollo de la arquitectura en 6 meses (Mes 1 a Mes 6); arquitectura objetivo con horizonte de 24 meses.
Dominios	Negocio, datos, aplicaciones y tecnología, con la seguridad como preocupación transversal.

6.3 Contenido incluido por dominio

Tabla 11
Contenido incluido en cada dominio de arquitectura

Dominio	Contenido incluido
Negocio	Modelo de capacidades; cadena de valor del paciente; procesos de consulta externa (actual y objetivo); roles y actores; modelo de gobierno de la arquitectura
Datos	Entidades maestras (paciente, profesional, unidad, servicio, medicamento); modelo lógico del expediente clínico; clasificación de sensibilidad en cuatro niveles; dueños de datos y reglas de calidad
Aplicaciones	Inventario de aplicaciones actuales; portafolio objetivo; servicios de aplicación; catálogo de interfaces con estándares (HL7 FHIR, DICOM)
Tecnología	Inventario de infraestructura; plataforma objetivo de cómputo, almacenamiento, red y conectividad; respaldo y continuidad; protección eléctrica; servicios de seguridad

6.4 Fuera del alcance

1. Diseño detallado de abastecimiento, logística y administración financiera (solo como contexto).
2. Diseño detallado de hospitalización y emergencia (solo nivel de contexto en esta iteración).
3. Adquisición, licenciamiento o desarrollo de software (se recomienda en las Fases E y F; se ejecuta en proyectos posteriores).
4. Implementación física de infraestructura y migración de datos (se planifican en la Fase F; se ejecutan después del Mes 6).
5. Operación y mantenimiento de las soluciones (responsabilidad de la OSI).

7. Limitaciones y restricciones

7.1 Limitaciones organizacionales

Tabla 12
Limitaciones organizacionales

Código	Limitación	Efecto en el trabajo de arquitectura
LO-01	El equipo de arquitectura solo accede a información agregada o anonimizada	No se consultan historias clínicas ni datos personales identificables
LO-02	El acceso a información institucional requiere autorización de cada área	Las sesiones de levantamiento se coordinan con los enlaces designados
LO-03	La función de arquitectura no está formalizada	Su formalización es condición previa (sección 13)
LO-04	No existe un inventario consolidado de sistemas	El inventario se levanta en el Mes 3 y condiciona las Fases C y D
LO-05	La continuidad de la atención impide detener servicios	Toda propuesta de transición incluirá coexistencia y reversión
LO-06	La carga asistencial limita la disponibilidad del personal clínico	Sesiones cortas, fuera de las horas de mayor demanda y con tiempo protegido

7.2 Limitaciones presupuestarias

Tabla 13
Limitaciones presupuestarias

Código	Limitación	Efecto
PB-01	El presupuesto anual es cerrado y no admite recursos extraordinarios para infraestructura	La arquitectura objetivo se implementará por etapas, priorizando las brechas de mayor impacto
PB-02	El presupuesto de corto plazo es referencial hasta su validación	Planeamiento y Presupuesto debe confirmarlo antes de la firma
PB-03	El presupuesto de implementación depende de las alternativas de solución	Se cuantifica en las Fases E y F

7.3 Limitaciones externas y normativas

Tabla 14
Limitaciones externas y normativas

Código	Limitación	Fuente	Responsable de atenderla
LE-01	Los datos de salud son datos sensibles y exigen cifrado, control de acceso, auditoría y anonimización de datos de prueba	Ley N.° 29733 (2011)	OSI
LE-02	Toda solución de historia clínica electrónica debe alinearse al RENHICE y a la norma técnica de gestión de la historia clínica	Ley N.° 30024 (2013); Ministerio de Salud (2018)	Dirección Asistencial y OSI
LE-03	La interoperabilidad sectorial depende de decisiones de la DIRESA Huánuco y del MINSA	Rectoría sectorial	Dirección Ejecutiva
LE-04	El Repositorio de Arquitectura debe residir en un espacio institucional del hospital	Política institucional	Administrador del Repositorio
LE-05	La vigencia del instrumento de planificación estratégica debe confirmarse	Planeamiento institucional	Planeamiento y Presupuesto

8. Enfoque de gestión

El enfoque de gestión describe cómo se conducirá el proyecto día a día: cómo se planifica, cómo se informa el avance, cómo se controla la calidad y cómo se toman decisiones.

8.1 Método de trabajo

El proyecto sigue el ciclo ADM de TOGAF 9.1, fase por fase, con un hito de aprobación al cierre de cada una. Dentro de cada fase se trabaja en ciclos semanales: levantamiento con las áreas, modelado, revisión interna del equipo y validación con los interesados. La Gestión de Requisitos se ejecuta de forma continua durante todo el ciclo, como establece TOGAF (The Open Group, 2011, cap. 17).

8.2 Seguimiento y reportes

Tabla 15
Mecanismos de seguimiento del proyecto

Mecanismo	Contenido	Frecuencia	Responsable	Destinatario
Reunión de equipo	Avance de la semana, bloqueos, plan de la semana siguiente	Semanal	Arquitecto líder	Equipo y enlaces
Informe de avance	Avance contra el plan, riesgos, cambios, decisiones pendientes	Mensual	Arquitecto líder	Comité de Seguimiento y ARB
Sesión del ARB	Revisión y aprobación de entregables; decisiones de cambio	Quincenal	Secretario del ARB	ARB
Informe de cierre de fase	Entregables aprobados, lecciones aprendidas, riesgos que pasan a la siguiente fase	Al cierre de cada fase	Arquitecto líder	Patrocinador

8.3 Escalamiento

Los problemas se resuelven en el nivel más bajo posible. Si el equipo no puede resolver un problema en cinco días hábiles, lo escala al Comité de Seguimiento; si el Comité no lo resuelve en la siguiente reunión, lo eleva al ARB; y si el problema afecta el presupuesto, el plazo total o los objetivos, el ARB lo eleva al patrocinador (Figura 2).

8.4 Gestión de la calidad

1. Cada entregable usa la plantilla oficial de The Open Group adaptada en la Fase Preliminar.
2. Cada entregable pasa por revisión de pares dentro del equipo antes de enviarse al ARB.
3. Los modelos se elaboran con el lenguaje ArchiMate (The Open Group, 2019) en una herramienta de modelado, para asegurar consistencia entre vistas.

4. Cada requisito se registra con identificador y trazabilidad hacia metas, principios y objetivos.

8.5 Gestión documental

El Administrador del Repositorio publica cada versión aprobada sin sobrescribir las anteriores. Los entregables se nombran con su código, título y versión (por ejemplo, *A-02_Declaracion_de_Trabajo_de_Arquitectura_v2.0*). Ningún documento contiene datos personales identificables de pacientes.

8.6 Gestión de la comunicación

La comunicación con los interesados se ejecuta según el Plan de Comunicaciones (A-03), que define canales, mensajes, responsables y calendario.

9. Procedimiento de cambio de alcance

Todo cambio en el alcance, los objetivos, los entregables, el plazo o el presupuesto acordados en esta Declaración debe seguir el siguiente procedimiento. Su propósito es que el alcance no crezca sin control y que cada cambio aprobado quede documentado.

9.1 Pasos del procedimiento

1. **Solicitud.** Cualquier interesado presenta una solicitud de cambio por escrito al arquitecto líder, indicando qué desea cambiar y por qué.
2. **Registro.** El secretario del ARB asigna un código (SC-nn) y registra la solicitud en el Registro de Decisiones de Arquitectura.
3. **Evaluación de impacto.** En un plazo máximo de cinco días hábiles, el equipo evalúa el efecto del cambio sobre el alcance, el plazo, el costo, los riesgos y los principios de arquitectura.
4. **Clasificación y decisión.** El cambio se clasifica y lo decide la instancia correspondiente (Tabla 16).
5. **Comunicación.** La decisión se comunica al solicitante y a los interesados afectados.
6. **Actualización.** Si el cambio se aprueba, se actualizan esta Declaración y los entregables afectados con una nueva versión.

9.2 Clasificación de cambios

Tabla 16
Niveles de cambio y autoridad de decisión

Nivel	Criterio	Decide
Menor	No afecta objetivos, plazo de fase ni presupuesto (por ejemplo, ajustar el orden de las sesiones de levantamiento)	Comité de Seguimiento
Mayor	Afecta el alcance de un dominio o el plazo de una fase, sin alterar el plazo total ni el presupuesto	ARB
Crítico	Afecta los objetivos de arquitectura, el plazo total del proyecto o el presupuesto	Patrocinador, previa recomendación del ARB

10. Roles, responsabilidades y entregables

10.1 Roles del proyecto

Tabla 17
Roles y responsabilidades

Rol	Sigla	Responsabilidades	Dedicación estimada
Patrocinador	PAT	Aprueba la Declaración y los cierres de fase; asigna recursos; decide cambios críticos	Hitos
Architecture Review Board	ARB	Revisa y aprueba entregables; aprueba excepciones; decide cambios mayores	2 horas quincenales
Arquitecto líder	AL	Dirige el proyecto; integra los dominios; redacta Visión, Declaración, hoja de ruta y gobierno; secretario del ARB	Tiempo completo, Mes 1 a Mes 6
Arquitecto de negocio	AN	Capacidades, procesos y escenario de negocio; línea base de tiempos de espera	Tiempo completo, Mes 1 a Mes 5
Arquitecto de datos	AD	Entidades maestras, modelo lógico, clasificación de sensibilidad, calidad de datos	Tiempo completo, Mes 2 a Mes 5
Arquitecto de aplicaciones y tecnología	AAT	Inventarios, portafolio de aplicaciones, interfaces, plataforma tecnológica	Tiempo completo, Mes 2 a Mes 5
Enlace clínico	EC	Representa al personal médico y de enfermería; valida procesos y requisitos clínicos	6 horas semanales
Enlace de la OSI	OSI	Provee información técnica; apoya los inventarios; valida la viabilidad operativa	8 horas semanales
Planeamiento y Presupuesto	OPP	Valida presupuesto, instrumentos de planificación e indicadores	Por hito
Administrador del Repositorio	AR	Versiona y publica los entregables	2 horas semanales

10.2 Entregables del proyecto

La siguiente tabla lista todos los entregables comprometidos en esta Declaración, agrupados por fase. Los nombres siguen la terminología de entregables de TOGAF 9.1 (The Open Group, 2011, cap. 36).

Tabla 18

Entregables comprometidos por fase

Código	Entregable	Entregable TOGAF equivalente	Fase	Semana de entrega
A-01	Visión de la Arquitectura	*Architecture Vision*	A	7
A-02	Declaración de Trabajo de Arquitectura (este documento)	*Statement of Architecture Work*	A	7
A-03	Plan de Comunicaciones	*Communications Plan*	A	5
A-04	Evaluación de Capacidades (incluye preparación para la transformación)	*Capability Assessment*	A	6
A-05	Definición de la Arquitectura, borrador v0.1	*Architecture Definition Document (draft)*	A	7
B-01	Definición de la Arquitectura de Negocio	*Architecture Definition Document* (negocio)	B	12
B-02	Especificación de Requisitos de Arquitectura de Negocio	*Architecture Requirements Specification* (negocio)	B	12
C-01	Definición de la Arquitectura de Datos	*Architecture Definition Document* (datos)	C	15
C-02	Definición de la Arquitectura de Aplicaciones (incluye inventario de aplicaciones)	*Architecture Definition Document* (aplicaciones)	C	15
C-03	Especificación de Requisitos de Sistemas de Información	*Architecture Requirements Specification* (datos y aplicaciones)	C	15
TEC-01	Definición de la Arquitectura Tecnológica (incluye inventario de infraestructura)	*Architecture Definition Document* (tecnología)	D	16
TEC-02	Especificación de Requisitos Tecnológicos	*Architecture Requirements Specification* (tecnología)	D	16
E-01	Hoja de Ruta de Arquitectura (versión inicial)	*Architecture Roadmap*	E	18
E-02	Estrategia de Implementación y Migración, con arquitecturas de transición	*Implementation and Migration Strategy*; *Transition Architecture*	E	18
F-01	Plan de Implementación y Migración, con hoja de ruta final	*Implementation and Migration Plan*	F	20
G-01	Modelo de Gobierno de la Implementación	*Implementation Governance Model*	G	23
G-02	Modelo de Contrato de Arquitectura	*Architecture Contract*	G	23
G-03	Procedimiento de Evaluación de Conformidad	*Compliance Assessment*	G	23
H-01	Procedimiento de Gestión del Cambio de Arquitectura	*Change Request* (procedimiento)	G y H	23
GR-01	Registro de Requisitos de Arquitectura	Repositorio de requisitos	Transversal	Continuo
GV-01	Registro de Decisiones de Arquitectura	Repositorio de gobierno	Transversal	Continuo

Nota. Los entregables de la Fase D se codifican como TEC-nn para no confundirlos con los entregables de la Fase Preliminar, que usan el prefijo D (por ejemplo, D-02 y D-06).

10.3 Matriz de responsabilidades (RACI)

En la matriz, R significa responsable de elaborar, A quien aprueba y rinde cuentas, C quien es consultado e I quien es informado.

Tabla 19
Matriz RACI por grupo de entregables

Entregable	PAT	ARB	AL	AN	AD	AAT	EC	OSI	OPP
A-01 Visión de la Arquitectura	A	C	R	C	C	C	C	C	C
A-02 Declaración de Trabajo	A	C	R	C	I	I	I	C	C
A-03 Plan de Comunicaciones	I	A	R	C	I	I	C	I	I
A-04 Evaluación de Capacidades	I	A	R	C	C	C	C	C	I
A-05 Definición v0.1	I	A	R	C	C	C	I	C	I
B-01 y B-02 Negocio	I	A	C	R	C	I	C	I	C
C-01 y C-03 Datos	I	A	C	C	R	C	C	C	I
C-02 Aplicaciones	I	A	C	C	C	R	C	C	I
TEC-01 y TEC-02 Tecnología	I	A	C	I	C	R	I	C	I
E-01, E-02 y F-01 Hoja de ruta y migración	A	C	R	C	C	C	C	C	C
G-01 a G-03 y H-01 Gobierno	A	C	R	I	I	C	I	C	I
GR-01 y GV-01 Registros	I	A	R	C	C	C	I	I	I

11. Criterios y procedimiento de aceptación

11.1 Criterios generales

Todo entregable se acepta solo si cumple los seis criterios siguientes:

1. **Forma:** usa la plantilla adaptada, tiene control de versiones y lista de distribución.
2. **Trazabilidad:** cada elemento relevante se vincula con al menos una meta de negocio, un principio y un objetivo de arquitectura.
3. **Consistencia:** no contradice otros entregables aprobados, en especial la Visión de la Arquitectura y esta Declaración.
4. **Validación:** los interesados señalados como consultados en la matriz RACI han revisado el contenido y sus observaciones están registradas.
5. **Protección de datos:** no contiene información personal identificable de pacientes.
6. **Comprensibilidad:** incluye un resumen ejecutivo entendible para la Dirección.

11.2 Criterios específicos

Tabla 20
Criterios específicos de aceptación por grupo de entregables

Entregables	Criterio específico de aceptación
Fase A	Visión validada por los actores clave; escenario EB-01 validado por la Dirección Asistencial; KPI convalidados por Planeamiento y Presupuesto; condiciones previas cumplidas
Fase B	Proceso actual y objetivo de consulta externa validados por al menos dos jefaturas médicas; línea base de KPI-01 y KPI-02 medida
Fase C	Modelo lógico del expediente compatible con el RENHICE; matriz de acceso por rol aprobada; inventario de aplicaciones validado por la OSI
Fase D	Inventario de infraestructura validado por la OSI; plataforma objetivo con solución de continuidad ante cortes de energía y conectividad
Fases E y F	Hoja de ruta con proyectos priorizados por valor y riesgo; cada etapa con costo estimado y mecanismo de coexistencia y reversión
Fase G	Modelo de gobierno y contratos de arquitectura aprobados por el ARB; procedimiento de cambio operativo

11.3 Procedimiento de aceptación

1. El responsable (R) entrega el documento al Comité de Seguimiento con una semana de anticipación a la sesión del ARB.
2. El Comité verifica los criterios generales y lo incluye en la agenda.
3. Los integrantes del ARB y los consultados envían sus observaciones en un máximo de cinco días hábiles, clasificadas como *bloqueantes* (impiden la aprobación) o *no bloqueantes* (se corrigen en la siguiente versión).

4. El responsable levanta las observaciones bloqueantes en un máximo de cinco días hábiles.
5. El ARB decide en sesión: **aprobado**, **aprobado con observaciones** (no bloqueantes, con plazo de corrección) o **rechazado** (vuelve al paso 4).
6. La decisión se registra en un acta con número y se publica la versión aprobada en el Repositorio.

Si un entregable es rechazado dos veces, el ARB lo escala al patrocinador para decidir si se ajusta el alcance o el plazo mediante el procedimiento de cambio (sección 9).

12. Plan de trabajo y cronograma

12.1 Cronograma por fases

El cronograma es el mismo que se adoptó en la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 38) y reemplaza las fechas de la versión 1.0. El Mes 1 comienza con el inicio de la Fase A; la Fase Preliminar ya está concluida.

Tabla 21
Cronograma del desarrollo de la arquitectura por mes

Fase	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
A. Visión de la Arquitectura	■■■■	■■■■				
B. Arquitectura de Negocio			■■■■			
C. Arquitecturas de Sistemas de Información			■■	■■■		
D. Arquitectura Tecnológica				■■■■		
E. Oportunidades y Soluciones					■■	
F. Planificación de la Migración					■■	
G. Gobierno de la Implementación						■■■
Cierre del ciclo						■
Gestión de Requisitos (continua)	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■

Nota. Cada cuadro representa una semana aproximada. Las Fases C y D se superponen parcialmente porque el inventario tecnológico se levanta junto con el de aplicaciones.

12.2 Plan detallado de actividades

Tabla 22
Actividades principales por semana

Semanas	Fase	Actividades principales	Entregables
1 a 2	A	Instalación del ARB; designación de enlaces; confirmación de metas y principios; identificación de interesados	Acta de instalación del ARB
3 a 4	A	Evaluación de capacidades y de preparación; entrevistas a actores clave	Borrador de A-04
5 a 6	A	Definición del alcance; escenario EB-01; arquitecturas base y objetivo v0.1; KPI y riesgos	A-03, A-04
7	A	Consolidación y revisión del ARB	A-01, A-02, A-05
8	A	Levantamiento de observaciones; firma del patrocinador	**Hito H1: Declaración aprobada**
9 a 10	B	Modelo de capacidades; proceso actual de consulta externa; medición de línea base de tiempos y de completitud de historias	Línea base KPI-01 y KPI-02
11 a 12	B	Proceso objetivo; análisis de brechas de negocio; requisitos de negocio	B-01, B-02 (**Hito H2**)
11 a 12	C	Inventario de aplicaciones; entidades maestras	Inventario de aplicaciones
13 a 15	C	Modelo lógico del expediente; clasificación de sensibilidad; portafolio objetivo e interfaces	C-01, C-02, C-03 (**Hito H3**)
13 a 16	D	Inventario de infraestructura; plataforma objetivo; continuidad y seguridad	TEC-01, TEC-02 (**Hito H4**)
17 a 18	E	Consolidación de brechas; paquetes de trabajo; arquitecturas de transición	E-01, E-02 (**Hito H5**)
19 a 20	F	Priorización por valor y riesgo; estimación de costos; plan de migración	F-01 (**Hito H6**)
21 a 23	G	Modelo de gobierno; contratos de arquitectura; procedimiento de conformidad y de cambio	G-01, G-02, G-03, H-01 (**Hito H7**)
24	Cierre	Informe de cierre del ciclo y lecciones aprendidas	Informe de cierre (**Hito H8**)

12.3 Hitos de control

Tabla 23
Hitos del proyecto

Hito	Descripción	Semana	Aprueba
H1	Fin de la Fase A: Declaración de Trabajo aprobada	8	Patrocinador y ARB
H2	Arquitectura de negocio aprobada	12	ARB
H3	Arquitecturas de datos y aplicaciones aprobadas	15	ARB
H4	Arquitectura tecnológica aprobada	16	ARB
H5	Hoja de ruta inicial y estrategia de migración aprobadas	18	ARB
H6	Plan de implementación y migración aprobado	20	Patrocinador y ARB
H7	Modelo de gobierno de la implementación aprobado	23	ARB
H8	Cierre del ciclo de desarrollo de la arquitectura	24	Patrocinador

13. Condiciones previas a la aprobación

La evaluación de preparación para la transformación (A-01, sección 8.2; A-04) mostró que faltan patrocinio formal, gobierno constituido y financiamiento. Por ello, esta Declaración solo surte efecto cuando se cumplen las siguientes condiciones:

Tabla 24
Condiciones previas a la aprobación de la Declaración

N.°	Condición	Evidencia requerida	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Autorización formal de la Dirección para desarrollar la arquitectura empresarial	Memorando o resolución directoral	Dirección Ejecutiva	Semana 2	Pendiente
2	Designación del patrocinador y de los responsables de la Tabla 7	Resolución directoral	Dirección Ejecutiva	Semana 2	Pendiente
3	Instalación del Architecture Review Board	Acta de instalación con quórum	Dirección Ejecutiva	Semana 2	Pendiente
4	Formalización de la función de arquitectura empresarial propuesta en el Modelo Organizacional (D-02)	Resolución directoral	Dirección Ejecutiva	Semana 8	Pendiente
5	Designación del enlace clínico y del enlace de la OSI con dedicación protegida	Memorando de designación	Dirección Asistencial y OSI	Semana 2	Pendiente
6	Entrega del instrumento de planificación estratégica y del Plan Operativo Institucional vigentes	Documentos aprobados	Planeamiento y Presupuesto	Semana 4	Pendiente
7	Validación del presupuesto de corto plazo (sección 14.1) y emisión de la certificación de crédito presupuestario	Informe de Planeamiento y certificación	Planeamiento y Presupuesto	Semana 7	Pendiente
8	Aprobación por el ARB de A-01, A-03 y A-04	Acta del ARB	ARB	Semana 7	Pendiente

14. Información presupuestaria

TOGAF distingue dos niveles de inversión: el necesario para producir la arquitectura y el necesario para implementarla. Esta Declaración compromete solo el primero; el segundo se estima en las Fases E y F.

14.1 Nivel 1: presupuesto de corto plazo (desarrollo de la arquitectura)

Los importes siguientes son **referenciales**, estimados por el equipo de arquitectura con base en remuneraciones habituales del sector público regional. Deben ser validados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (condición previa 7).

Tabla 25
Presupuesto referencial de corto plazo

Concepto	Supuesto de cálculo	Importe referencial (S/)	Fuente de financiamiento
Arquitecto líder	6 meses × S/ 7000	42 000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Arquitecto de negocio	5 meses × S/ 5500	27 500	Recursos ordinarios (por confirmar)
Arquitecto de datos	4 meses × S/ 5500	22 000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Arquitecto de aplicaciones y tecnología	4 meses × S/ 5500	22 000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Herramienta de modelado	Archi, herramienta gratuita y de código abierto para ArchiMate	0	No aplica
Capacitación en TOGAF y ArchiMate para el equipo, la OSI y el ARB	Curso de 40 horas	8000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Repositorio de Arquitectura	Espacio en servidor institucional existente, más respaldo externo	2000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Levantamiento de información	Movilidad, materiales, medición de tiempos y auditoría de historias	3000	Recursos ordinarios (por confirmar)
Sesiones de gobierno	Materiales y logística de 12 sesiones del ARB	1500	Recursos ordinarios (por confirmar)
Subtotal		**128 000**	
Contingencia	10 % del subtotal	12 800	
Total referencial		**140 800**	

Nota. El costo de personal puede reducirse si el hospital asigna personal propio a los roles de arquitectura o suscribe un convenio con la Universidad Nacional Agraria de la Selva para incorporar practicantes de la Facultad de Ingeniería en Informática y Sistemas como apoyo al levantamiento, bajo la dirección del arquitecto líder.

14.2 Nivel 2: presupuesto de largo plazo (implementación de la arquitectura)

Tabla 26
Componentes del presupuesto de implementación y momento de su cuantificación

Componente	Momento de cuantificación	Base de la estimación
Software del expediente clínico y de gestión de citas	Fase E	Alternativas evaluadas (adquisición, desarrollo o solución sectorial)
Infraestructura de cómputo y almacenamiento	Fases D y E	Inventario y dimensionamiento
Red, conectividad redundante y protección eléctrica	Fases D y E	Inventario y requisitos de continuidad
Integración con el MINSA, la DIRESA y el SIS	Fase E	Catálogo de interfaces
Migración y depuración de datos	Fase F	Volumen y calidad de datos
Capacitación del personal y gestión del cambio	Fase F	Número de usuarios y plan de despliegue
Soporte y mantenimiento	Fase F	Modelo operativo de la OSI
Partida recurrente de la función de arquitectura	Fase G	Modelo de gobierno

15. Supuestos y riesgos del proyecto

15.1 Supuestos

Tabla 27
Supuestos del proyecto

Código	Supuesto	Valida	Fecha objetivo	Estado
S-D-01	La estructura organizativa se mantiene estable durante los seis meses	Dirección Ejecutiva	Semana 4	Pendiente
S-D-02	Las metas de negocio BG-001 a BG-004 son las vigentes	Planeamiento y Presupuesto	Semana 4	Pendiente
S-D-03	Los integrantes del equipo de arquitectura se incorporan en las fechas de la Tabla 17	Dirección Ejecutiva	Semana 2	Pendiente
S-D-04	Las áreas participan en las sesiones de trabajo según el calendario de A-03	Dirección Asistencial	Semana 5	Pendiente
S-D-05	La OSI proporciona información técnica no sensible para los inventarios	OSI	Semana 9	Pendiente

15.2 Riesgos del proyecto

Los riesgos de la *transformación del negocio* se gestionan en el registro de la Visión de la Arquitectura (A-01, Tabla 34). A continuación, se registran los riesgos propios de la *ejecución del proyecto* de arquitectura, con su nivel inicial y residual (The Open Group, 2011, cap. 31).

Tabla 28
Registro de riesgos del proyecto

Código	Riesgo	Riesgo inicial	Mitigación	Riesgo residual	Responsable
R-D-01	La Declaración no se firma y el ciclo no se inicia formalmente	Alto	Llevar las condiciones previas a la sesión de instalación del ARB (semana 2)	Bajo	Dirección Ejecutiva
R-D-02	El presupuesto de corto plazo no se valida a tiempo	Alto	Presentar el presupuesto referencial en la semana 4; usar personal propio o convenio universitario como alternativa	Medio	Planeamiento y Presupuesto
R-D-03	El inventario de sistemas e infraestructura no se completa y retrasa las Fases C y D	Alto	Enlace de la OSI con dedicación protegida; fecha comprometida ante el ARB	Bajo	OSI
R-D-04	El personal clínico no asiste a las sesiones y los procesos no se validan	Medio	Sesiones cortas en horas de menor demanda; respaldo de la Dirección Asistencial	Bajo	Dirección Asistencial
R-D-05	El ARB no logra quórum y los entregables se acumulan sin aprobar	Medio	Calendario anual de sesiones; posibilidad de sesión virtual	Bajo	Secretario del ARB
R-D-06	El alcance crece sin control por nuevas solicitudes	Medio	Aplicación estricta del procedimiento de cambio (sección 9)	Bajo	Arquitecto líder
R-D-07	Salida de un integrante del equipo durante el proyecto	Medio	Documentación continua en el Repositorio; trabajo en pares	Bajo	Arquitecto líder

16. Conclusiones

1. Esta Declaración convierte la Visión de la Arquitectura en un compromiso ejecutable: define qué se entregará, quién lo hará, en qué plazo, con qué recursos y cómo se aceptará.
2. El alcance se acota a la cadena de atención de consulta externa, porque la evaluación de preparación mostró que el hospital aún no tiene las condiciones para abordar todos los procesos a la vez.
3. El enfoque de gestión, el procedimiento de cambio y la matriz de responsabilidades permiten controlar el proyecto y resolver desacuerdos con base en lo pactado.
4. El trabajo de arquitectura requiere una inversión referencial de S/ 140 800 en seis meses, sujeta a validación, y deja la cuantificación de la implementación para las Fases E y F, cuando existan alternativas concretas.
5. La firma de esta Declaración por el patrocinador, una vez cumplidas las condiciones previas, cierra la Fase A y autoriza el inicio de la Fase B.

17. Referencias

Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales*. Diario Oficial El Peruano.

Congreso de la República del Perú. (2013). *Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas*. Diario Oficial El Peruano.

Josey, A. (2011). *TOGAF® versión 9.1: Guía de bolsillo*. Van Haren Publishing.

Ministerio de Salud. (2018). *NTS N.° 139-MINSA/2018/DGAIN, Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica* (Resolución Ministerial N.° 214-2018/MINSA).

Poder Ejecutivo del Perú. (2018). *Decreto Legislativo N.° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital*. Diario Oficial El Peruano.

The Open Group. (2011). *TOGAF® Version 9.1*. Van Haren Publishing.

The Open Group. (2019). *ArchiMate® 3.1 Specification*. Van Haren Publishing.

Nota. Al exportar el documento a Word, la lista de referencias debe llevar sangría francesa de 1,27 cm, conforme a APA 7.

18. Apéndices

Apéndice A. Siglas

Tabla A1
Siglas utilizadas en el documento

Sigla	Significado
ADM	Método de Desarrollo de Arquitectura (*Architecture Development Method*)
ARB	Junta de Revisión de Arquitectura (*Architecture Review Board*)
DIRESA	Dirección Regional de Salud
KPI	Indicador clave de desempeño
MINSA	Ministerio de Salud
OSI	Oficina de Sistemas y Información del hospital
RACI	Responsable, Aprueba, Consultado, Informado
RENHICE	Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas
SC	Solicitud de cambio
SIS	Seguro Integral de Salud

Apéndice B. Trazabilidad entre la petición, los objetivos y los entregables

Tabla B1
Trazabilidad entre los cambios solicitados, los objetivos y los entregables que los atienden

Cambio solicitado (D-06)	Objetivo	Entregables que lo atienden
1. Automatizar la consulta externa	OA-02	B-01, B-02, C-02, E-01
2. Expediente único y accesible	OA-01	C-01, C-02, C-03, TEC-01
3. Reducir tiempos de espera	OA-02	B-01 (línea base y proceso objetivo), F-01
4. Seguridad y privacidad	OA-03	C-01 (clasificación y acceso), TEC-01, TEC-02
5. Indicadores del Plan Operativo	OA-07	B-01, C-01, C-02
Añadido por A-01: interoperabilidad	OA-04	C-02 (interfaces), TEC-01
Añadido por A-01: función de arquitectura	OA-05	Condición previa 4; G-01, G-02, G-03, H-01
Añadido por A-01: capacitación	OA-06	B-02, C-02, F-01

Apéndice C. Formato de solicitud de cambio

Tabla C1
Campos de la solicitud de cambio

Campo	Contenido
Código	SC-nn (asignado por el secretario del ARB)
Solicitante y fecha	Nombre, cargo y fecha de presentación
Descripción del cambio	Qué se desea cambiar
Justificación	Por qué es necesario
Entregables afectados	Códigos de los entregables
Impacto evaluado	Alcance, plazo, costo, riesgo y principios
Nivel	Menor, mayor o crítico
Decisión	Aprobado, aprobado con condiciones o rechazado; instancia y número de acta

19. Hoja de aprobación

Esta Declaración de Trabajo de Arquitectura surte efecto cuando se han cumplido las condiciones previas de la sección 13 y ha sido firmada por el patrocinador y aprobada por el ARB.

19.1 Aprobación del patrocinador

Tabla 29
Firma del patrocinador

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
	Director(a) Ejecutivo(a) del Hospital de Tingo María		

19.2 Aprobación del Architecture Review Board

Tabla 30
Decisión del ARB

Nombre	Cargo en el ARB	Decisión	Fecha	N.° de acta
	Presidente (Director[a] Ejecutivo[a])			
	Director(a) Asistencial			
	Director(a) de Administración			
	Jefe(a) de Planeamiento y Presupuesto			
	Jefe(a) de la Oficina de Sistemas y Información			
	Secretario (arquitecto líder, sin voto)			

19.3 Conformidad del equipo de arquitectura

Tabla 31
Conformidad del responsable de la elaboración

Nombre	Rol	Firma	Fecha
	Arquitecto líder		